

Treinamento de habilidades para cuidadores voltado para famílias de crianças com atraso no desenvolvimento ou deficiência

Introdução



Treinamento de habilidades para cuidadores voltado para famílias de crianças com atraso no desenvolvimento ou deficiência

Introdução

Brasília, D.F., 2026

OPAS



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde

Região das Américas

Versão oficial em português da obra original em inglês
Caregiver skills training for families of children with developmental delays or disabilities: introduction
© Organização Mundial da Saúde, 2022
ISBN: 978-92-4-004883-6 (versão eletrônica)

Treinamento de habilidades para cuidadores voltado para famílias de crianças com atraso no desenvolvimento ou deficiência - Introdução
ISBN: 978-92-75-73041-6 (PDF)
ISBN: 978-92-75-23041-1 (versão impressa)

© Organização Pan-Americana da Saúde, 2026

Alguns direitos reservados. Esta obra está disponível nos termos da licença Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Organizações Intergovernamentais da Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO).



De acordo com os termos da licença, é permitido copiar, redistribuir e adaptar a obra para fins não comerciais, desde que se utilize a mesma licença ou uma licença equivalente da Creative Commons e que ela seja citada corretamente, conforme indicado abaixo. Nenhuma utilização desta obra deve dar a entender que a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) endossa uma determinada organização, produto ou serviço. Não é permitido utilizar o logotipo da OPAS.

Adaptações: em caso de adaptação da obra, deve-se acrescentar, juntamente com a forma de citação sugerida, o seguinte aviso legal: "Esta publicação é uma adaptação de uma obra original da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). As opiniões expressas nesta adaptação são de responsabilidade exclusiva dos autores e não representam necessariamente a posição da OPAS".

Traduções: em caso de tradução da obra, deve-se acrescentar, juntamente com a forma de citação sugerida, o seguinte aviso legal: "Esta publicação não é uma obra original da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). A OPAS não assume nenhuma responsabilidade pelo conteúdo nem pela exatidão da tradução".

Citação sugerida: Organização Pan-Americana da Saúde. Treinamento de habilidades para cuidadores voltado para famílias de crianças com atraso no desenvolvimento ou deficiência - Introdução. Brasília, D.F.; 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.37774/9789275730416>.

Dados da catalogação: podem ser consultados em: <http://iris.paho.org>.

Vendas, direitos e licenças: para adquirir publicações da OPAS, entrar em contato com sales@paho.org. Para solicitações de uso comercial e consultas sobre direitos e licenças, ver www.paho.org/es/publicaciones/permisos-licencias.

Materiais de terceiros: caso um usuário deseje reutilizar material contido nesta obra que seja de propriedade de terceiros, como tabelas, figuras ou imagens, cabe a ele determinar se necessita de autorização para tal reutilização e obter a autorização do detentor dos direitos autorais. O risco de ações de indenização decorrentes da violação de direitos autorais pelo uso de material pertencente a terceiros recai exclusivamente sobre o usuário.

Avisos legais gerais: as denominações utilizadas nesta publicação e a forma como os dados são apresentados não implicam nenhum juízo, por parte da OPAS, com respeito à condição jurídica de países, territórios, cidades ou zonas ou de suas autoridades nem com relação ao traçado de suas fronteiras ou limites. As linhas tracejadas nos mapas representam fronteiras aproximadas sobre as quais pode não haver total concordância.

A menção a determinadas empresas comerciais ou aos nomes comerciais de certos produtos não implica que sejam endossados ou recomendados pela OPAS em detrimento de outros de natureza semelhante. Salvo erro ou omissão, nomes de produtos patenteados são grafados com inicial maiúscula.

A OPAS adotou todas as precauções razoáveis para confirmar as informações constantes desta publicação. Contudo, o material publicado é distribuído sem nenhum tipo de garantia, expressa ou implícita. O leitor é responsável pela interpretação do material e seu uso; a OPAS não poderá ser responsabilizada, de forma alguma, por qualquer prejuízo causado por sua utilização.

BRA/NMH/2026

Projeto gráfico de Harri Aittasalo; ilustrações de Miguel Mendes.

Sumário

Prefácio	iv
Agradecimentos	v
Antecedentes	1
A quem se destina o pacote de treinamento de habilidades para cuidadores?	1
Formato do pacote de treinamento de habilidades para cuidadores	1
Ferramentas de implementação do treinamento de habilidades para cuidadores	2
Estrutura e metas das sessões em grupo	2
Estrutura e metas da visita domiciliar	2
Conteúdo do pacote de treinamento de habilidades para cuidadores	3
Métodos educacionais	4
Quem pode oferecer o curso de treinamento de habilidades para cuidadores?	4
Quem pode treinar e supervisionar os facilitadores?	4
Treinamento de facilitadores	5
Supervisão	5
Como usar o <i>Guia do facilitador</i>	6
Como gerir as sessões em grupo	6

Prefácio

Esta é a primeira parte do pacote *Treinamento de habilidades para cuidadores voltado para famílias de crianças com atraso no desenvolvimento ou deficiência*. Este pacote de cursos, dividido em cinco partes, oferece orientação — apresentada em forma de texto e em um conjunto de estratégias parentais ilustradas — para aumentar a capacidade dos cuidadores de promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças por meio de rotinas do brincar e rotinas de casa estruturadas.

Os cuidadores desempenham um papel fundamental na promoção de ambientes acolhedores. Intervenções psicossociais e intervenções mediadas pelos pais podem melhorar as trajetórias de desenvolvimento, a funcionalidade e a qualidade de vida de crianças com deficiência no desenvolvimento. No entanto, a maioria das crianças com tais problemas e seus cuidadores não têm acesso a esses cuidados.

O pacote de treinamento de habilidades para cuidadores foi concebido para ser ministrado por pessoas não especialistas treinadas. O treinamento adota uma abordagem centrada na família, permitindo que os provedores de cuidados ofereçam o apoio necessário aos cuidadores na definição de metas de treinamento específicas para cada família. O pacote de treinamento é destinado a cuidadores de crianças de 2 a 9 anos de idade com atraso no desenvolvimento ou deficiência e tem como objetivo fornecer a eles habilidades que podem ser usadas em casa para melhorar o engajamento da criança em atividades e na comunicação, além de promover comportamentos positivos e habilidades para a vida diária. O curso foi elaborado para ser integrado em uma rede de serviços sociais e de saúde baseados na comunidade para crianças com deficiência no desenvolvimento e suas famílias. Ele deve ser ministrado como parte da abordagem de “cuidados escalonados” para a saúde infantil, na qual o tratamento mais efetivo, mas com o menor uso de recursos, é administrado antes de se “avançar” para serviços mais especializados.

Durante o teste de campo nos diferentes países, constatou-se que o pacote de treinamento de habilidades para cuidadores era viável, bem aceito e relevante como intervenção para as famílias, contribuindo para melhorar as habilidades parentais dos cuidadores e seu bem-estar.

Esperamos que, após a adaptação deste pacote de treinamento para atender ao contexto local nos diferentes países, ele alcance um número maior de famílias e contribua para que cuidadores e crianças com deficiência no desenvolvimento alcancem o bem-estar e tenham relações saudáveis e melhor qualidade de vida.

Dévora Kestel

Diretora

Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias Psicoativas, Organização Mundial da Saúde, Genebra

Agradecimentos

Coordenação do projeto

A elaboração e a testagem em campo do pacote de treinamento de habilidades para cuidadores foram coordenados por Chiara Servili sob a direção de Tarun Dua, Shekhar Saxena (até 2018) e Dévora Kestel (a partir de 2019), Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias Psicoativas da OMS.

Desenvolvimento do conteúdo

Principais colaboradores

(em ordem alfabética, com a filiação institucional no momento da colaboração)

Especialistas externos: Felicity L. Brown (War Child Holland e Universidade de Amsterdã, Países Baixos), Laura Pacione (Universidade de Toronto, Canadá), Erica Salomone (Universidade de Milano-Bicocca, Itália), Stephanie Shire (Universidade de Oregon, Estados Unidos da América [EUA]).

Equipe técnica da OMS: Chiara Servili (Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias Psicoativas, sede)

Análise e insumos técnicos

(em ordem alfabética, com a filiação institucional no momento da análise)

Especialistas externos: Nazmin Abdullah (Universidade de Kebangsaan, Malásia), Amina Abubakar (KEMRI- Wellcome Trust, Quênia), Julnar Al-Kaied (Corpo Médico Internacional, República Árabe Síria), Carlos G. Alonso-Rivera (Associação Internacional de Pediatria, México), Ana Andreeva-Sapundzhieva (Centro para Reabilitação e Integração Social, Bulgária), Maria Paz Araya (Ministério da Saúde, Chile), Anara Asanalieva (Centro para Crianças com Autismo, Quirguistão), Gulnaz Azhymambetova (Departamento de Saúde, Quirguistão), Alexandra Bagney (Médicos Sem Fronteiras, Espanha), Merry Barua (Action for Autism, Índia), Tolulope Bella-Awusah (Universidade de Ibadan, Nigéria), Erlinda Borrromeo (Autism Hearts Foundation, EUA), Daniel Bulte (Universidade de Oxford, Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte [Reino Unido]), July Caballero (Ministério de Saúde Mental, Peru), Carmen Julissa Cayo Medina (Instituto Nacional de Saúde Mental, Peru), Ya-Chih Chang (Autism Speaks, EUA), Tony Charman (King's College London, Reino Unido), Biyuan Chen (Universidade Sun Yat-Sen, China), Mariana Chervenкова (Autism Today Association, Bulgária), Chung-Hsin Chiang (NCU, Taipei), Youngmin Choi (República da Coreia), Brian Cort (Canadá), Carla Cortez (Peru), Sebastián Cukier (PANAACEA, Argentina), Cristiane Silvestre de Paula (Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasil), Luc de Montigny (Universidade McGill, Canadá), Petrus De Vries (Universidade da Cidade do Cabo, África do Sul), Limia Dewan (Centro BRAC, Bangladesh), Marie-Charlotte Dextraze (Madawaska Valley Homeschoolers, Canadá), Gauri Divan (Sangath, Índia), Pamela Dixon (Autism Speaks, EUA), Winnie Dorego (Eastern Visayas Centre for Health Development, Filipinas), Svyatoslav Dovbnya (Naked Heart Foundation, Federação da Rússia), Dzhamilia Dunganova (Universidade Estadual de Quirguiz, Quirguistão), Patrick Dwyer (Universidade da Califórnia, Davis, EUA), Julian Eaton (CBM West Africa, Togo), Aala El-Khani (Universidade de Manchester, Reino Unido), Mayada Elsabbagh (Universidade McGill, Canadá), Mohamed Ali AbdulFattah Mohamed ElShazly (Corpo Médico Internacional, Turquia), Camilla Ferrante (Universidade de Milano-Bicocca, Itália), Magdalene Foo (Instituto de Saúde Mental, Singapura), Natsuko Fukuda (República da Coreia), Daniel Fung Shuen Sheng (Instituto de Saúde Mental, Singapura), Galiya Gaas (Hand in Hand, Quirguistão), Eman Gaber (Universidade do Cairo, Egito), Fe Garcia (Visão Mundial Internacional, EUA), Ricardo Garcia (Universidade do Chile, Chile), Jason Garner (Dubai Health Care City, Emirados Árabes Unidos), Tewodros Getye (Centro de Autismo Nehemiah,

Etiópia), Mehdi Ghanadzade (Instituto VRF, República Islâmica do Irã), Lucky Ghose (Centro BRAC, Bangladesh), Deepa Grover (UNICEF), Sudhanshu Grover (Action for Autism, Índia), Fiorella Guerrero (Universidade da Flórida, EUA), Hailiang Guo (Fundação de Desenvolvimento das Mulheres, China), Syed Usman Hamdani (Fundação de Pesquisa em Desenvolvimento Humano, Paquistão), Charlotte Hanlon (Universidade de Adis Abeba, Etiópia), Sarah Louise Harrison (Corpo Médico Internacional, Turquia), Homayoun Hashemi (Organização Estatal de Bem-Estar do Irã, República Islâmica do Irã), Paola Hebe Jelonche (Fundação Visibilia, Argentina), Rosa Hoekstra (King's College Londres, Reino Unido), Maria del Milagro Huaman Lu (Soy Autista y Que!, Peru), Yasmin Hussain (SEAMEO SEN, Malásia), Judy Hutchings (Universidade Bangor, Reino Unido), Alaa Ibrahim (Universidade McGill, Canadá), Ivan Ivanov (Centro de Apoio Comunitário, Bulgária), Seokyeon Ji (República da Coreia), Sazlina Kamaralzaman (Universidade de Kebangsaan, Malásia), Tsveta Kamensky (UNICEF Bulgária), Connie Kasari (Universidade da Califórnia, EUA), Raheleh Khansari (Organização Estatal de Bem-estar do Irã, República Islâmica do Irã), Leekyung Kim (República da Coreia), Yeni Kim (República da Coreia), Yongjik Kim (Sociedade de Autismo da Coreia, República da Coreia), Margarita Kinshina (Ministério da Saúde, Federação da Rússia), Phiona Naserian Koyiet (World Vision, Quênia), Vibha Krishnamurthy (Ummeed Child Development Center, Índia), Kim Kwang-Hee (República da Coreia), Samer Laila (Corpo Médico Internacional, Turquia), Pierina Landolfi (PANAACEA, Argentina), Layma Lankmane (The Way Out Fund, Federação da Rússia), Janet Lau (Universidade de Hong Kong, China, RAE de Hong Kong), Rachel Leung (China, RAE de Hong Kong), Janice Light (Universidade Estadual da Pensilvânia, EUA), Miroslava Macheva (Centro Comunitário de Apoio à Criança e aos Pais, Bulgária), Milena Marinova (UNICEF Bulgária), Rositsa Markova (Centro de Cuidados Complexos para Crianças com Deficiência e Doenças Crônicas, Bulgária), Helen McConachie (Universidade de Newcastle, Reino Unido), Sharynne McLeod (Universidade Charles Sturt, Austrália), Nermeen Abdelaziz M. Moharam (Médecins du Monde, Egito), Inna Monova (Naked Heart Foundation, Federação da Rússia), Cecilia Montiel Nava (Autism Speaks, EUA), Carina Morillo (Fundación Brincar por un autismo feliz, Argentina), Tatiana Morozova (Naked Heart Foundation, Federação da Rússia), Lucia Murillo (Autism Speaks, EUA), Basma T. M. Nakhleh (Sociedade de Pediatria da Palestina, território ocupado da Palestina, incluindo Jerusalém Oriental), Young Namkung (República da Coreia), Thi Nha Trang Nguyen (Vinschool Primary, Vietnã), Bolajoko Olusanya (Centre for Healthy Start Initiative, Nigéria), Elisey Osin (The Way Out Fund, Federação da Rússia), Narges Parastari Farkoosh (Organização Estatal de Bem-Estar do Irã, República Islâmica do Irã), Diane Philipp (Universidade de Toronto, Canadá), Shawn Picard (Canadá), Rolando Pomalima (Instituto Nacional de Saúde Mental, Peru), Maryam Pourseid (Organização Estatal de Bem-Estar do Irã, República Islâmica do Irã), Marie-Helen Prud'homme (Centro de Saúde da Universidade McGill, Canadá), Atif Rahman (Universidade de Liverpool, Reino Unido), Rocio del Pilar Ramirez Flores (Instituto Nacional de Saúde Mental, Peru), Salvador Ramírez Gallegos (México), Alexia Rattazzi (PANAACEA, Argentina), Kara Reagon (Autism Speaks, EUA), Brian Reichow (Universidade da Flórida, EUA), Peter Rosenbaum (CanChild Centre, Canadá), Cécile Rousseau (Universidade McGill, Canadá), Eoin Ryan (Corpo Médico Internacional, EUA), Sayed Abdullah Sadat (MBC, República Islâmica do Irã), Bettina Schwethelm (UNICEF), Mawathage Fatima Sudarshi Perera Seneviratne (Universidade de Colombo, Sri Lanka), Koyeli Sengupta (Ummeed Child Development Center, Índia), Hibah Abdullah Shata (Centro Médico de Intervenção Precoce Infantil, Emirados Árabes Unidos), Rehana Sherif Yekatit (12 Hospital, Etiópia), Andy Shih (Autism Speaks, EUA), Kimberlee Shoecraft (International Rescue Committee, EUA), Norbert Skokauskas (Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, Noruega), Sofia Sol Hilsenrat (Fundación Brincar por un autismo feliz, Argentina), Wei-Tsuen Soong (China), Maria Stancheva (Centro de Reabilitação e Integração Social, Bulgária), Claudine Storbeck (Centre for Deaf Studies – HI HOPES – Universidade de Witwatersrand, África do Sul), Delfina Suaya (Ministério de Saúde da Província de Buenos Aires, Argentina), Inyoung Sung (República da Coreia), Markos Tesfaye (Universidade Jimma, Etiópia), Hasnah Toran (Permata Kurnia, Malásia), Vivek Prabhakar Vajaratkar (Centro Sangath, Índia), Elie S. Valencia (Universidade Columbia, EUA), Desislava Vassileva (Autism Today Association, Bulgária), Krista Vick (Universidade de Saskatchewan, Canadá), Manuela Wälchli (Suíça), Saima Wazed Hossain (Fundação Shuchona, Bangladesh),

Inka Weissbecker (Corpo Médico Internacional, EUA), Nickoleta Yoncheva (Karin Dom, Bulgária), Anastasia Zalogina (Naked Heart Foundation, Federação da Rússia), Xiaobing Zou (Universidade Sun Yat-Sen, China).

Equipe técnica da OMS: Claudina Cayetano (Escritório Regional para as Américas), Ken Carswell (Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias Psicoativas, sede), Bernadette Daelmans (Departamento de Saúde Materna, Neonatal, Infantil e Adolescente e Envelhecimento, sede), Pauline Kleinitz (Doenças Não Transmissíveis, sede), Khalid Saeed (Escritório Regional para o Mediterrâneo Oriental), Sabine Van Tuyll Van Serooskerken Rakotomalala (Departamento de Determinantes Sociais da Saúde, sede).

Contribuição financeira

A OMS agradece o apoio financeiro da Autism Speaks.

Antecedentes

O pacote de cinco partes do *Treinamento de habilidades para cuidadores voltado para famílias de crianças com atraso no desenvolvimento ou deficiência* foi elaborado para facilitar o acesso de cuidadores de crianças com atraso no desenvolvimento ou deficiência ao apoio parental. A elaboração dos materiais do pacote de treinamento baseou-se em evidências sobre intervenções parentais e mediadas pelos pais para crianças com deficiência no desenvolvimento. Em particular, levaram-se em consideração evidências de estratégias voltadas para cuidadores de crianças com atraso ou deficiência nos domínios sociais e de comunicação. O pacote de treinamento foi elaborado em consulta com especialistas internacionais, prestadores de serviços, cuidadores e defensores dos interesses das famílias, sendo aprimorado com base em seu feedback e amplamente testado em campo em diversas regiões.

A quem se destina o pacote de treinamento de habilidades para cuidadores?

O público-alvo são cuidadores de crianças de 2 a 9 anos que apresentam atraso no desenvolvimento ou deficiência, com foco específico nos cuidadores de crianças com atrasos ou comprometimentos nas áreas social e de comunicação, embora a faixa etária possa ser ajustada ligeiramente conforme as necessidades do contexto. É importante ressaltar que não é necessário um diagnóstico para acessar o curso. A falta de um requisito de diagnóstico significa que o pacote de treinamento pode ser fornecido às famílias assim que um atraso no desenvolvimento for identificado. Isso pode reduzir outras possíveis barreiras, inclusive a possível relutância dos cuidadores em se identificarem como pais de crianças com deficiência no desenvolvimento, bem como o estigma associado à participação de um curso rotulado como sendo exclusivo para cuidadores de crianças com problemas de desenvolvimento. A expectativa é que o curso de treinamento de habilidades para cuidadores seja recomendado às famílias por provedores de atenção primária à saúde, agentes comunitários de saúde, prestadores de serviços educacionais ou especialistas.

Formato do pacote de treinamento de habilidades para cuidadores

O curso foi concebido para ser ministrado em nove sessões em grupo básicas para cuidadores e três visitas domiciliares. As sessões em grupo podem ser realizadas em um estabelecimento de saúde, escola ou outro estabelecimento da comunidade. Cada sessão em grupo dura de 2,5 a 3 horas, que inclui um intervalo. As sessões podem ser semanais ou quinzenais, dependendo do que for mais viável para os cuidadores no contexto local. As visitas domiciliares são agendadas no início, no meio e no final do curso, ou seja, antes da sessão em grupo 1, entre as sessões 5 e 6 e após a sessão em grupo final. Em geral, as visitas domiciliares são realizadas na casa dos cuidadores e duram de 1,5 a 2 horas. No entanto, caso não sejam viáveis devido à distância, problemas de segurança ou outras dificuldades, também podem ser realizadas em um ambiente comunitário. Normalmente, dois cuidadores por domicílio são convidados a participar das sessões em grupo. O curso básico de 9 sessões também foi adaptado para ser ministrado virtualmente por meio de videoconferência para sessões em grupo e visitas domiciliares.

Podem ser oferecidas sessões em grupo e visitas domiciliares adicionais para que haja mais tempo para adquirir estratégias relacionadas ao bem-estar dos cuidadores e estratégias adaptadas às necessidades dos cuidadores de crianças com pouco ou nenhum uso de linguagem falada.

Ferramentas de implementação do treinamento de habilidades para cuidadores

Além desta introdução, há quatro partes subsequentes do pacote de treinamento de habilidades para cuidadores, enquanto duas partes adicionais estão sendo desenvolvidas:

- *Guia de adaptação e implementação.*
- *Guia do facilitador:* sessões em grupo 1 a 9.
- *Guia do participante:* sessões em grupo 1 a 9.
- *Guia de visita domiciliar para facilitadores.*
- Cuidadores de crianças com pouco ou nenhum uso de linguagem falada: guias do facilitador e do participante (a serem publicados).
- Bem-estar do cuidador: guias do facilitador e do participante (a serem publicados).

Estrutura e metas das sessões em grupo

Uma estrutura geral das sessões em grupo deve ser seguida para as sessões 2 a 9, e inclui:

- Uma atividade rápida de bem-estar (respiração calma).
- Um resumo das mensagens-chave e dicas da sessão anterior.
- Discussão das experiências com o treino em casa.
- Apresentação da história de um cuidador ilustrada no *Guia do participante* (as histórias de cuidadores servem para transmitir mensagens educacionais, fornecer exemplos de como as estratégias podem ser implementadas em casa e explorar experiências comuns de cuidadores), seguida de perguntas guiadas para estimular o aprendizado e a discussão.
- Aprendizagem e atividades em grupo, com a apresentação das mensagens-chave e dicas da sessão.
- Um intervalo.
- Demonstração, pelos facilitadores, de habilidades e estratégias usando encenação, seguida de perguntas guiadas para aprendizagem e discussão em grupo.
- Planejamento do treino em casa e prática de habilidades por meio de encenação com facilitadores, orientação personalizada e feedback.
- Revisão da sessão e encerramento.

O curso de treinamento de habilidades para cuidadores é uma intervenção mediada pelo cuidador que integra essas estratégias à vida cotidiana. Entre os objetivos das sessões em grupo estão melhorar os conhecimentos e as habilidades dos cuidadores e, ao mesmo tempo, dar apoio para praticarem com a criança, em casa, as estratégias aprendidas.

O treino em casa entre as sessões em grupo é fundamental; os cuidadores devem praticar as habilidades aprendidas diariamente com a criança.

Estrutura e metas da visita domiciliar

As metas das visitas domiciliares abrangem: estabelecer um vínculo com a família, inclusive com os familiares que não participam das sessões em grupo, para aprender sobre as competências de desenvolvimento da criança e seu comportamento e o ambiente domiciliar; ajudar o cuidador a definir metas para a criança; orientação personalizada para ajudar o cuidador a pôr em prática as estratégias aprendidas nas sessões em grupo; resolução dos problemas enfrentados pelos cuidadores; estimular o comparecimento às sessões em grupo; e identificar quaisquer necessidades adicionais da família e encaminhá-la a outros serviços, quando necessário.

Cada visita domiciliar tem tarefas e metas específicas que são detalhadas no *Guia de visita domiciliar para facilitadores*.

A estrutura geral da visita domiciliar inclui:

- Cumprimentar a família e a criança.
- Discussão com o cuidador sobre questões específicas para essa visita. A visita 1 abrange fazer um histórico do contato da família com os serviços de apoio e avaliar o comportamento de comunicação e a funcionalidade da criança. As visitas 2 e 3 incluem uma revisão das estratégias das mensagens-chave e o treino em casa.
- Observação do cuidador interagindo com a criança e interação entre o facilitador e a criança.
- Demonstração, pelo facilitador, das habilidades e estratégias (dicas) do treinamento de habilidades para cuidadores e orientação personalizada sobre essas estratégias.
- Definição de metas com base na observação e entrevista com o cuidador. As metas são identificadas na visita 1 e discutidas e revisadas na visita 2 e na visita 3.
- Planejamento para o futuro. As visitas 1 e 2 consistem em convidar a família para a próxima sessão e discutir possíveis obstáculos e soluções. Já a visita 3 compreende a criação de um plano para continuar praticando as estratégias do treinamento de habilidades para cuidadores.

Toda visita domiciliar inclui uma avaliação das necessidades das famílias. Os facilitadores devem estar atentos a sinais que indiquem a necessidade de suportes adicionais, como problemas de saúde da criança ou do cuidador, dificuldades de saúde mental e suspeita de maus-tratos infantis ou privação material.

Conteúdo do pacote de treinamento de habilidades para cuidadores

A base teórica e a metodologia do curso se fundamentam em princípios de análise do comportamento aplicada, ciência do desenvolvimento, intervenções de comunicação social, parentalidade positiva e métodos de autocuidado. Especificamente, o pacote de treinamento de habilidades para cuidadores se baseia em abordagens comportamentais naturalistas e de desenvolvimento para promover o engajamento conjunto e a comunicação, incluindo JASPER (sigla em inglês para atenção compartilhada, jogo simbólico, engajamento e regulação) e PRT (sigla em inglês para treinamento de resposta fundamental); abordagens de parentalidade positiva para promover o comportamento positivo das crianças e o manejo de comportamentos desafiadores; resolução de problemas e promoção do bem-estar do cuidador.¹

O objetivo das duas primeiras sessões em grupo é engajar a criança em atividades (tanto atividades domésticas do dia a dia quanto atividades do brincar) e mantê-la engajada. A sessão em grupo 3 trata de como criar rotinas do brincar e rotinas de casa para estimular o engajamento, a comunicação, o comportamento positivo e habilidades para a vida diária. As sessões 4 e 5 têm a finalidade de ensinar a reconhecer as habilidades de comunicação da criança e criar oportunidades para estimular a comunicação. O enfoque da Sessão 6 é ensinar habilidades para o cotidiano em pequenos passos, com diferentes níveis de ajuda. Nas sessões 7 e 8, o enfoque é aprender a estimular comportamentos positivos e reduzir comportamentos desafiadores. A Sessão 9 é dedicada ao bem-estar do cuidador, à resolução de problemas e à definição de metas para a continuação da prática.

¹ Para obter mais detalhes, consulte as seguintes fontes:

Kasari C, Lawton K, Shih W, Barker TV, Landa R, Lord C et al. (2014). Caregiver-mediated intervention for low-resourced preschoolers with autism: an RCT. *Pediatrics*. 2014;134(1):e72-9.

Kaale A, Smith L, Sponheim E. A randomized controlled trial of preschool-based joint attention intervention for children with autism. *J Child Psychol Psychiatry*. 2012;53(1):97-105.

Kasari C, Gulsrud A, Paparella T, Hellemann G, Berry K. Randomized comparative efficacy study of parent-mediated interventions for toddlers with autism. *J Consult Clin Psychol*. 2015;83(3):554-63.

Métodos educacionais

O curso de treinamento de habilidades para cuidadores baseia-se em métodos educacionais pertinentes à aprendizagem de adultos, inclusive a definição de metas pessoais, a aprendizagem ativa por meio de perguntas (perguntas guiadas para a aprendizagem) e discussões. O conhecimento e as experiências dos participantes são incorporados às sessões em grupo por meio de discussões e da troca de experiências sobre o treino em casa; os participantes têm a oportunidade de se beneficiar das ideias, experiências e sugestões de outras pessoas. A aprendizagem ativa é promovida por estratégias de ensino por meio de demonstrações dos facilitadores e atividades de prática dos participantes durante a sessão, com feedback e orientação personalizada dos facilitadores. A chave para a facilitação do curso de treinamento de habilidades para cuidadores é a criação de um ambiente de aprendizagem seguro e positivo, no qual os participantes se sintam à vontade para fazer e responder perguntas e compartilhar suas ideias e experiências com outros cuidadores.

Quem pode oferecer o curso de treinamento de habilidades para cuidadores?

Os facilitadores devem ser pessoas não especialistas, treinadas e supervisionadas (agentes comunitários de saúde, assistentes sociais, profissionais de enfermagem, facilitadores de educação na primeira infância, professores, cuidadores experientes, etc.). A seleção dos facilitadores deve levar em consideração o potencial de sustentabilidade e escalabilidade no contexto local. Os facilitadores devem ter tempo suficiente — de preferência, no seu horário de trabalho regular — para realizar as sessões em grupo do treinamento de habilidades para cuidadores e as visitas domiciliares. O tempo de deslocamento também deve ser considerado. De preferência, os facilitadores devem ter concluído o ensino médio ou equivalente. A experiência no cuidado de crianças com deficiência no desenvolvimento e na facilitação de grupos será um diferencial. Os facilitadores devem ser acessíveis e ter habilidades para trabalhar bem com outros adultos, mantendo um ambiente de apoio nas sessões em grupo e oferecendo feedback e orientação personalizada de forma solidária. Para isso, eles precisarão ser treinados nas habilidades e estratégias do treinamento de habilidades para cuidadores, tanto para conduzir as sessões em grupo quanto para fazer as visitas domiciliares.

Os facilitadores devem receber apoio e supervisão constante de um supervisor habilitado.

Quem pode treinar e supervisionar os facilitadores?

Os facilitadores devem ser treinados e supervisionados por instrutores principais e supervisores locais. Os instrutores principais e supervisores podem ser provedores de atenção primária à saúde não especialistas, como profissionais de medicina geral ou enfermagem, ou profissionais de saúde especializados, como pediatras, psiquiatras, psicólogos ou profissionais de enfermagem especialistas em saúde mental, desde que tenham sido capacitados para ministrar o pacote de treinamento de habilidades para cuidadores. Quanto aos critérios de seleção adicionais para instrutores principais e supervisores, sugere-se uma formação mínima de educação formal em desenvolvimento infantil ou em saúde mental, em nível pós-secundário ou equivalente. É importante ter experiência clínica ou pessoal anterior significativa com crianças com deficiência no desenvolvimento. Os supervisores devem ser treinados no uso do pacote de treinamento de habilidades para cuidadores e ter experiência pessoal na realização de sessões em grupo e visitas domiciliares. A experiência em treinamento e supervisão é um diferencial.

Treinamento de facilitadores

Uma estratégia sugerida para o treinamento de facilitadores é a seguinte:

- Um treinamento em sala de aula de três dias (Curso inicial, parte 1) ministrado por instrutores principais locais e que abranja o principal conteúdo e as estratégias para as sessões em grupo 1 a 5, facilitação de grupos e habilidades de visitas domiciliares.
- Experiência de campo envolvendo a realização conjunta de sessões em grupo 1 a 5 e visitas domiciliares 1 e 2 a um grupo de participantes cuidadores com um instrutor principal ou supervisor. Sessões programadas para instrutores para *debriefing* e orientação com instrutores principais ou supervisores após cada sessão em grupo e visita domiciliar (20 a 30 minutos).
- Um segundo treinamento em sala de aula com duração de três dias (Curso inicial, parte 2) ministrado por instrutores principais locais e que ofereça uma visão geral do principal conteúdo e das estratégias para as sessões em grupo 6 a 9, facilitação de grupos e habilidades de visitas domiciliares.
- Experiência de campo adicional proporcionada pela realização conjunta das sessões em grupo 6 a 9 e da visita domiciliar 3 a um grupo de cuidadores participantes, com um instrutor principal ou supervisor, com períodos previstos de *debriefing* e orientação após cada sessão em grupo e visita domiciliar.
- Um treinamento adicional de dois dias concentra-se em habilidades avançadas, facilitação de grupos, resolução de problemas, habilidades de resolução de problemas e orientação personalizada para cuidadores.
- Experiência adicional de prática, treinamento ou cofacilitação, a critério dos instrutores principais ou supervisores.
- Mais experiência de campo será adquirida com a realização conjunta de um curso completo de treinamento de habilidades para cuidadores, abrangendo nove sessões em grupo básicas e três visitas domiciliares, realizadas com um grupo de cuidadores participantes e outro facilitador em treinamento, e com sessões previstas de supervisão após cada sessão em grupo e visita domiciliar.
- Supervisão contínua durante a realização do curso de treinamento de habilidades para cuidadores em parceria com outro facilitador; Isso deve incluir, no mínimo, uma verificação formal após cada visita domiciliar. Recomenda-se a realização de um *debriefing* com os instrutores principais ou supervisores após cada sessão em grupo, embora isso possa ser feito gradualmente, à medida que os facilitadores adquirem experiência. No entanto, os instrutores principais ou supervisores devem estar disponíveis para esclarecer dúvidas ou preocupações.

Supervisão

A supervisão dos facilitadores é essencial e deve ser realizada, no mínimo, após cada visita domiciliar. A modalidade pode ser presencial ou virtual, e a supervisão pode ser realizada em grupo. Já a supervisão por pares poderá ser implementada quando houver um grupo experiente de facilitadores.

No entanto, um instrutor principal ou supervisor deve estar sempre disponível para resolver problemas e orientação. A supervisão individual (por exemplo, em resposta a uma preocupação urgente de um participante com relação a uma criança) também deve estar disponível, conforme necessário, como parte de um modelo de supervisão em grupo.

A supervisão envolve:

- Discussão das competências de desenvolvimento da criança em termos de nível de brincar, habilidades de comunicação, comportamento e habilidades da vida diária (auxiliada por uma gravação em vídeo da primeira visita domiciliar).

- Determinação das habilidades-alvo para a criança com base em suas competências de desenvolvimento.
- Escolha de metas adequadas de cuidadores para a criança.
- Discussão de eventuais necessidades adicionais da família relacionadas à saúde da criança, saúde mental do cuidador, suspeita de maus-tratos infantis, etc.
- Discussão sobre visitas domiciliares, orientação personalizada, dificuldades ou obstáculos ao comparecimento às sessões.
- Discussão de desafios relacionados à dinâmica de grupo.
- Discussão sobre experiências positivas e êxitos dos cuidadores com as crianças.
- Encenação para ilustrar como lidar com dificuldades ou praticar habilidades (para melhorar as habilidades dos facilitadores em gerenciamento de grupos, orientação personalizada, etc.).
- Avaliação contínua da carga de trabalho do facilitador.
- Atenção ao autocuidado do facilitador.

Como usar o *Guia do facilitador*

Os facilitadores devem ter o manual em mãos durante as sessões e consultá-lo com frequência para saber o que fazer e para ler as perguntas, as instruções ou os roteiros sugeridos (destacados *em itálico*).

Coisas práticas a considerar

Número de facilitadores

- O curso de treinamento de habilidades para cuidadores deve ser ministrado por facilitadores trabalhando em pares. As sessões em grupo requerem dois facilitadores. As visitas domiciliares podem ser conduzidas individualmente pelos facilitadores.

Número de cuidadores por grupo

- Os grupos podem ter de 6 a 12 participantes.
- Dois cuidadores de cada família devem ser convidados a participar.

Como gerir as sessões em grupo

As habilidades a seguir são necessárias para gerir as sessões em grupo do treinamento de habilidades para cuidadores.

Ficar dentro do tempo sem interromper discussões valiosas em grupo

- Vale a pena lembrar aos participantes os horários definidos durante a intervenção.
- Os intervalos podem ser usados para retornar às discussões em grupo que precisaram ser abreviadas.
- Às vezes, você pode decidir que uma discussão em grupo é importante demais e precisa continuar, e, portanto, decide abreviar outra parte da sessão (veja o exemplo a seguir). Se optar por fazer isso, pense em como organizar o tempo para abordar o tópico que foi pulado (por exemplo, pedir ao grupo para ficar mais tempo, chegar mais cedo da próxima sessão, reduzir os intervalos, etc.). Sempre converse com seu supervisor sobre essas decisões para ter certeza de que você não ignorou informações importantes.
 - Por exemplo, uma discussão sobre como um participante está aplicando uma estratégia em casa está demorando mais do que o esperado. Você decide continuar essa discussão porque

percebe que outros participantes também estão aprendendo sobre a estratégia e como podem aplicá-la em suas próprias vidas.

Gerenciar participantes que falam muito ou muito pouco nas sessões em grupo

- Alguns participantes podem falar muito nas discussões, interferindo na participação dos demais. Eles podem interromper, falar ao mesmo tempo que as outras pessoas ou discordar das experiências ou opiniões de outros participantes. Nessa situação, os facilitadores devem usar suas habilidades para gerenciar essas pessoas durante as sessões em grupo.
 - Por exemplo: *“Obrigado (nome). O que você está dizendo é útil, mas também gostaríamos de ouvir as opiniões das outras pessoas do grupo. Alguém mais estaria disposto a compartilhar sua experiência com o treino em casa?”*
 - Se essa dificuldade persistir, considere a possibilidade de falar com seu supervisor.
- No caso de participantes que não falam muito, considere conversar individualmente com eles para ajudá-los a participar do grupo.
 - Por exemplo: *“Percebi que você está muito quieto no grupo. Posso fazer algo para ajudá-lo a se envolver mais nas discussões?”*

Gerenciar discussões em grupo que fujam do assunto ou identificar estratégias inúteis ou que estejam fora do escopo do curso de treinamento de habilidades para cuidadores

- Recomenda-se que os facilitadores sejam firmes ao redirecionar as discussões em grupo. Os facilitadores podem fazer uso de habilidades básicas de ajuda. Por exemplo: *“Eu entendo que essa é uma discussão interessante, mas estamos nos afastando do foco da sessão. Vamos voltar ao tema e discutir esse assunto durante o intervalo.”*
 - Por exemplo: *“Essa estratégia parece ter sido útil para você, mas agora precisamos continuar com as atividades desta sessão. Podemos conversar mais sobre isso durante a visita domiciliar/outra sessão em grupo.”*

Como responder a respostas incorretas ou parcialmente corretas

- Perguntas guiadas para aprendizagem fazem parte das sessões em grupo. Elas foram elaboradas para ajudar os cuidadores a pensar e discutir o material. Seu objetivo não é testar o conhecimento do cuidador.
- É importante responder a respostas incorretas ou parcialmente corretas de forma solidária que promova um ambiente de aprendizagem seguro no qual os cuidadores se sintam à vontade para assumir riscos, compartilhar suas ideias e fazer e responder perguntas.
 - Por exemplo (para uma resposta incorreta): *“Na verdade, a demonstração deveria ilustrar [uma estratégia específica do treinamento de habilidades para cuidadores]. Isso faz sentido?”*
 - Por exemplo (para uma resposta parcialmente correta): *“Sim, e o cuidador na demonstração também usou outras estratégias. Alguém mais gostaria de compartilhar outra estratégia que tenha percebido?”*

Como estimular o comparecimento e reduzir a desistência

- O facilitador deve identificar proativamente os obstáculos ao comparecimento na primeira visita domiciliar e usar a técnica de resolução de problemas.
- Os facilitadores são orientados a conversar com os participantes que costumam faltar às sessões, relatam não fazer o treino em casa, chegam sempre atrasados ou saem mais cedo, etc. Além disso, devem demonstrar curiosidade, enfatizar o esforço que eles já estão fazendo no curso e ajudá-los a resolver problemas, se for o caso.

- Se um participante desistir, ele poderá precisar de um tipo diferente de ajuda ou serviço. Os facilitadores são orientados a discutir estratégias com seus supervisores para ajudar os participantes que desistiram do curso.
- Os facilitadores devem conversar com seus supervisores se estiverem preocupados com o fato de um participante estar perturbando o grupo.

Cuidadores e crianças em risco de danos ou que já estejam sofrendo danos

- Durante o curso das visitas domiciliares ou das sessões em grupo, é possível que os facilitadores se preocupem com o bem-estar de um cuidador ou de uma criança.
- Os facilitadores podem descobrir que um participante está sofrendo abuso (por exemplo, violência de gênero perpetrada por um parceiro) ou tem um problema de saúde mental (consulte o *Guia de visita domiciliar* para obter detalhes).
- Os facilitadores podem saber que uma criança está sendo negligenciada ou prejudicada por castigos físicos severos, que está se machucando ou sendo fisicamente violenta com outros membros da família.
- Os facilitadores podem ficar sabendo de tudo isso durante uma sessão em grupo ou visita domiciliar, ou outro cuidador pode lhe dizer que isso está acontecendo com alguém do grupo.
- Se um facilitador souber por terceiros que um cuidador ou criança está em risco ou está sofrendo danos, deverá conversar em particular com o participante sobre a situação.
- Se um cuidador temer pela sua própria segurança ou pela segurança de outra pessoa em casa, inclusive de suas próprias crianças, os facilitadores devem entrar em contato com seus supervisores imediatamente para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Tudo depende do contexto e das leis nacionais, mas as medidas podem envolver denunciar o abuso à polícia, a uma agência específica ou rede informal de proteção ou às autoridades locais. É importante que os facilitadores informem o participante sobre as medidas que serão tomadas para garantir a segurança do cuidador e/ou outras pessoas em sua casa.
- É aconselhável que os facilitadores sempre conversem com seus supervisores sobre cuidadores, crianças ou outros membros da família que suscitam preocupações.

Milhões de crianças em todo o mundo vivem com algum tipo de deficiência do desenvolvimento e, sem o apoio adequado, essas condições frequentemente limitam suas oportunidades de aprendizado, socialização e participação plena na vida em comunidade. Reconhecendo essa realidade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu um pacote de cinco módulos denominado *Caregiver Skills Training* (CST), ou Treinamento de Habilidades para Cuidadores, voltado a famílias e cuidadores de crianças com atraso no desenvolvimento ou deficiência. O CST oferece orientações práticas e acessíveis, apresentadas em formato textual e ilustrado, com estratégias parentais baseadas em evidências para fortalecer as competências dos cuidadores no apoio ao desenvolvimento e ao bem-estar das crianças, por meio de rotinas de brincar, comunicação e atividades cotidianas estruturadas em casa.

Esta introdução corresponde ao primeiro dos cinco módulos do CST. Ela apresenta o contexto e os fundamentos do programa, define o público-alvo e descreve o formato, os objetivos e as ferramentas utilizadas. Também detalha a estrutura e as metas das sessões em grupo e das visitas domiciliares, além de explicar o conteúdo de cada componente do pacote e os métodos educacionais empregados. O módulo aborda ainda quem pode oferecer o curso, como realizar o treinamento e a supervisão de facilitadores, e de que forma utilizar o Guia do Facilitador para planejar, conduzir e monitorar as sessões com qualidade. Assim, constitui uma base essencial para a implementação eficaz do programa CST em diferentes contextos e países.

OPAS



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde
Região das Américas

www.paho.org



9 789275 730416